KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Sinais vitais e interpretação

A dor como quinto sinal vital

Aula 4 de 5 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

A dor como quinto sinal vital

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Avaliar a intensidade, as características e a resposta ao tratamento da dor.

A dor é a razão mais comum pela qual as pessoas procuram cuidados de saúde e, por isso, deve ser avaliada sempre, como os outros sinais vitais. É uma experiência subjectiva: é o que o doente diz que é.

Nesta aula aprende a usar escalas, a caracterizar a dor, a avaliar doentes que não falam e a reavaliar após o tratamento.

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. Porque avaliar a dor sempre
3. Dor aguda e dor crónica
4. Escala numérica (0 a 10)
5. Outras escalas
6. Caracterizar a dor: PQRST
7. Sinais que acompanham a dor
8. Doentes que não conseguem dizer
9. Tratar a dor: escada analgésica
10. Reavaliar a dor
11. Caso: dor pós-operatória
12. Caso: resolução
13. Pontos-chave
14. Para reflectir
15. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Explicar porque a dor é o quinto sinal vital
2. Usar escalas numéricas, visuais e de faces
3. Caracterizar a dor com os critérios PQRST
4. Avaliar a dor em crianças e em doentes que não comunicam
5. Reavaliar a dor depois de uma intervenção

Porque avaliar a dor sempre

- A dor não tratada atrasa a recuperação e piora o sono, o humor e a mobilidade
- Pode ser o **primeiro sinal** de um problema grave (ex.: enfarte, apendicite)
- É **subjectiva**: acredite no doente
- O mesmo estímulo dói de forma diferente em cada pessoa
- Avalie na admissão, em cada turno, após procedimentos e depois de cada analgesia

Dor aguda e dor crónica

Característica	Aguda	Crónica
Duração	Dias ou poucas semanas	Mais de 3 meses
Causa	Lesão, cirurgia, doença	Doença persistente ou sensibilização
Sinais	Taquicardia, sudorese, ansiedade	Cansaço, depressão, sono alterado
Objectivo	Tratar a causa e aliviar	Função e qualidade de vida

Escala numérica (0 a 10)

Peça ao doente que dê uma nota: **0 = sem dor**, **10 = pior dor imaginável**.

Pontuação	Classificação
0	Sem dor
1 a 3	Dor ligeira
4 a 6	Dor moderada
7 a 10	Dor intensa

Use a mesma escala sempre que possível, para comparar ao longo do tempo.



Outras escalas

Escala	Para quem
Escala numérica (END)	Adultos e crianças maiores com capacidade de expressão
Escala visual analógica (EVA)	Adultos: linha de 10 cm marcada pelo doente
Escala de faces (Wong-Baker)	Crianças a partir dos 3 a 4 anos e pessoas com dificuldade de comunicação
FLACC	Crianças pequenas e doentes que não falam (cara, pernas, actividade, choro, consolo)
Escalas comportamentais (ex.: PAINAD)	Pessoas com demência avançada

Caracterizar a dor: PQRST

Letra	Pergunta
P	Provocação/paliação: o que a piora ou melhora?
Q	Qualidade: como é? (picada, queimadura, aperto, pressão)
R	Região e irradiação: onde dói e para onde vai?

Sinais que acompanham a dor

Na dor aguda, observe também:

- Taquicardia, hipertensão, taquipneia
- Palidez, sudorese, náuseas
- Face crispada, gemidos, posição de defesa, agitação
- Recusa em mover-se, imobilidade
- Na criança e no idoso: choro, irritabilidade, agitação, retraimento

Atenção: dor no peito com suor, náuseas e falta de ar deve ser comunicada de imediato.

Doentes que não conseguem dizer

- Crianças pequenas, bebés, pessoas com demência, intubadas ou com deficiência
- Observe **expressão facial, movimentos, choro, postura, resposta ao toque**
- Pergunte a familiares e cuidadores: eles reconhecem alterações
- Use escalas validadas (FLACC, PAINAD)
- Na dúvida, **trate e reavalie**

Tratar a dor: escada analgésica

A OMS propõe uma escada com 3 degraus, conforme a intensidade e **sempre por prescrição**:

1. **Dor ligeira:** analgésicos não opióides (paracetamol, anti-inflamatórios)
2. **Dor moderada:** opióides fracos (ex.: tramadol) ± não opióides
3. **Dor intensa:** opióides fortes (ex.: morfina) ± não opióides

Associe sempre **medidas não farmacológicas**: posicionar, frio ou calor, relaxamento, distracção, apoio emocional.

Reavaliar a dor

- Reavalie **30 a 60 minutos** depois de um analgésico (ou segundo o protocolo)
- Use a **mesma escala** e o mesmo momento do dia
- Se não aliviou, **comunique** ao médico para ajustar o tratamento
- Vigie efeitos adversos: sonolência, náuseas, depressão respiratória (opióides), alterações gástricas e renais (anti-inflamatórios)
- Registe: valor antes e depois, intervenção, resposta, hora

Caso: dor pós-operatória

Uma mulher de 38 anos, no 1.º dia após cirurgia abdominal, refere dor de 8/10. Está imóvel, com a face crispada, FC 108 bpm e FR 22 por minuto. Recusa mexer-se.

> **Pense antes de avançar:** o que faz?

Caso: resolução

1. **Valide** a queixa e avalie a dor completa (PQRST) e os outros sinais vitais
2. Verifique a **prescrição** analgésica e administre o que está prescrito
3. Associe medidas não farmacológicas: posição, apoio da ferida ao tossir, respiração calma
4. **Reavalie** a dor passados 30 a 60 minutos e registe
5. Se não melhorar, **comunique** ao médico para rever a analgesia
6. Incentive a mobilização precoce quando a dor estiver controlada

Pontos-chave

1. A dor avalia-se sempre e reavalia-se depois de tratar
2. Acredite no doente: a dor é subjectiva
3. Escala numérica: 0 a 10; use faces e FLACC quando necessário
4. PQRST caracteriza a dor
5. Escada analgésica da OMS e medidas não farmacológicas
6. Reavalie em 30 a 60 minutos e comunique se não melhorar

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Alguma vez desvalorizou a dor de um doente? O que aprendeu?

? Que escala usaria numa criança de 4 anos e porquê?

? Que medidas não farmacológicas pode aplicar no seu serviço?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ Escala visual analógica da dor (EVA)

→ Dor aguda (diagnóstico NANDA-I)

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser